HELP_Organi_P14 — Groupe C — Lots 232 à 236 — 16 questions

Questionnaire de recherche médicale pour l'encyclopédie PROFILES (examen fédéral suisse). Paquet 14 sur 30.

Consignes

1. Tu réponds de façon sourcée, jamais de mémoire. Sources suisses d'abord (OFSP, Swissmedic, AIPS sur swissmedicinfo.ch, Tox Info Suisse, Fedlex, ASSM, FMH, sociétés suisses), puis européennes (ESC, ERS, ERC, EASL, ESCMID, ESE, EULAR, EAACI, KDIGO, EMA). Jamais de recommandation exclusivement américaine.
2. Pour chaque question : recommandation suisse en vigueur (société ou autorité, titre, année, URL) ; version la plus récente comparée à la version citée dans le « Contexte », avec les différences ; informations, doses, posologies, voies et adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'AIPS, avec le numéro d'autorisation Swissmedic ; à défaut de source suisse, la recommandation européenne la plus récente.
3. Chaque réponse a sa propre source et son propre extrait mot pour mot, avec URL et date de consultation. Les formules « idem », « voir question X » ou une source recopiée sans extrait propre sont interdites.
4. Si aucune source fiable n'existe, écris « donnée non trouvée dans les sources consultées » et liste les sources consultées. N'invente jamais.
5. Au début, écris le nombre de questions reçues dans ce paquet. À la fin, rends exactement le même nombre de réponses, avec leurs numéros.
6. Fais ensuite auditer ce paquet par un agent distinct, en raisonnement élevé : URL existante, extrait présent dans la source, source suisse ou européenne la plus récente, dose conforme à l'AIPS. Il corrige ou marque « donnée non trouvée ». Il n'invente jamais.
7. Rends les réponses dans un Google Doc du dossier HELP nommé comme ce paquet, suivi de « _REPONSES ». Écris en français, en phrases verbales courtes.

Questions

C-036 — Moyenne — LOT 234 · SSP O7.12 ; O7.13

Emplacement : LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 234 Partie 2 DX.3 a DX.5 › Situation de départ (SSP) O7.12 — Infection sexuellement tra (lacune #13) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › sida (lacune #82) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › lymphocytes T CD4 (lacune #83) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Anémie (lacune #86) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Syndrome d'infection chronique non traitée (lacune #88) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › lymphocytes T CD4 (lacune #90) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Lacunes restantes (lacune #109)

Contexte : Le cours donne CD4 < 350/µL (présentation tardive) et < 200/µL (maladie avancée), mais pas la valeur normale des CD4, la liste des maladies définissant le sida, les signes de la phase chronique, le seuil d'anémie, ni la mortalité suisse du VIH.

Question : Quelle est la liste actuelle des maladies définissant le sida (CDC/ECDC/OMS), l'intervalle de référence des CD4 de l'adulte, les signes cliniques de la phase chronique (stade OMS 2–3), la définition de l'anémie (OMS) et la mortalité liée au VIH en Suisse (OFS, Swiss HIV Cohort Study) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-037 — Moyenne — LOT 234 · SSP O7.12

Emplacement : LOT_234_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 234 Plan et Liste › B2.2. Tableau comparatif des dix entités (lacune #6) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) › étude de Lausanne chez la femme enceinte (lacune #19) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) (lacune #20) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) (lacune #21) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) (lacune #23)

Contexte : Le cours suit l'IUSTI pour l'herpès génital (PCR HSV, valaciclovir 500 mg 2×/j, suppression qui réduit la transmission d'environ 50 %) ; l'incubation, l'incidence suisse, la mortalité et le seuil de biopsie des ulcérations ne sont pas donnés.

Question : Quelle est la recommandation européenne la plus récente sur l'herpès génital (IUSTI/WHO Europe, année, comparée à la version citée), avec durée d'incubation, indication de biopsie d'une ulcération génitale, et doses suisses de valaciclovir et aciclovir (primo-infection, récurrence, suppression, grossesse dès 36 SA) ? Existe-t-il des données suisses d'incidence ou de séroprévalence HSV-1/HSV-2 ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-038 — Moyenne — LOT 234 · SSP O7.12

Emplacement : LOT_234_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 234 Plan et Liste › B2.2. Tableau comparatif des dix entités (lacune #5) ; LOT 234 Partie 2 DX.3 a DX.5 › Situation de départ (SSP) O7.12 — Infection sexuellement tra › néoplasies intraépithéliales La néoplasie intraépithéliale désigne une (lacune #15) ; LOT 234 Partie 2 DX.3 a DX.5 › Situation de départ (SSP) O7.12 — Infection sexuellement tra (lacune #16) ; LOT 234 Partie 2 DX.3 a DX.5 › Situation de départ (SSP) O7.12 — Infection sexuellement tra › sinécatéchines Les sinécatéchines sont un extrait de feuilles de thé v (lacune #17)

Contexte : Le cours traite les condylomes (imiquimod 5 % Aldara®, sinécatéchines 10 % Veregen®, cryothérapie, chirurgie) ; la notification des partenaires, la classe pharmacologique des sinécatéchines et la sensibilité du diagnostic clinique manquent ; la couverture vaccinale HPV suisse citée date de 2021.

Question : Quelles sont la couverture vaccinale HPV suisse la plus récente (OFSP, filles et garçons), la recommandation européenne la plus récente (IUSTI) sur les verrues anogénitales, y compris l'information des partenaires, et le statut suisse de Veregen® et d'Aldara® (indication, durée maximale) ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les

adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-044 — Moyenne — LOT 234 · SSP O7.12

Emplacement : LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 234 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (situation de (lacune #8) ; LOT 234 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12 de (lacune #62)

Contexte : Le cours désigne le TAAN comme gold standard de C. trachomatis et la PCR de lésion pour le mpox, sans sensibilité ni spécificité chiffrées.

Question : Quelles sensibilités et spécificités publient les sources européennes (IUSTI, ECDC) pour le TAAN de C. trachomatis selon le site de prélèvement et pour la PCR mpox ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-045 — Moyenne — LOT 234 · SSP O7.12

Emplacement : LOT_234_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) › prise en charge par l’assurance et dépistage Constat. Le dépistage d’I (lacune #35) ; LOT 234 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 234 : Infection sexuellement transmissible (SSP O7.12) › partenaires, secret professionnel et assurance (lacune #50)

Contexte : Le cours écrit que le dépistage d'IST chez l'asymptomatique n'est pas à la charge de l'assurance de base, sauf programme cantonal ou communal.

Question : Quelles prestations de dépistage d'IST et de VIH l'OPAS couvre-t-elle en 2026 (y compris la PrEP et ses examens depuis 2024) et quels programmes cantonaux gratuits existent (Neuchâtel, Vaud, Genève) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :

5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-035 — Haute — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #93) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #94) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #95) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Lacunes restantes (lacune #110)

Contexte : Le cours dit qu'en cas d'échec ou de résistance, le schéma suit le génotype (darunavir boosté + deux INTI) sans dose ; le calendrier de surveillance EACS, l'imagerie et la marche à suivre pour le VIH-2 ne sont pas donnés.

Question : Quelles doses de darunavir boosté (Prezista®/Prezcobix®, Symtuza®) et quel schéma de deuxième intention recommande l'EACS 2025 (comparé à 2023) ? Quel calendrier de surveillance biologique de l'ART fixe l'EACS ? Quelle procédure suit le diagnostic du VIH-2 en Suisse (Centre national de référence pour les rétrovirus, directive OFSP 2025) ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-047 — Haute — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Fièvre (lacune #5) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Éosinophilie (lacune #6) ; LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Élévation de l'alanine aminotransférase (ALAT) (lacune #7) ; LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Fièvre (lacune #97) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #118) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › Lacunes restantes (lacune #129)

Contexte : Le cours définit fièvre, éosinophilie et élévation des ALAT sans seuil chiffré ; il utilise un consensus international [S408] pour l'éosinophilie et un seuil « selon le fabricant » pour la sérologie Strongyloides.

Question : Quels seuils chiffrés retiennent les sources suisses ou européennes pour la fièvre (°C, site de mesure), l'éosinophilie (légère, modérée, sévère, en /µL), l'élévation des ALAT (× limite supérieure, EASL) et la positivité des sérologies Strongyloides et Schistosoma (ELISA) chez le migrant ? Quelle conduite devant une éosinophilie chez un migrant (Swiss TPH, ESCMID) ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :

2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-048 — Haute — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_2_DX.3_a_DX.5.html › LOT 235 Plan et Liste › Lacunes restantes (lacune #18) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S31] (lacune #76) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › lecture du carnet de vaccination (lacune #77) ; LOT 235 Partie 2 DX.3 a DX.5 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S32] [S7] (lacune #78)

Contexte : Le cours utilise le Plan de vaccination suisse 2026 faute de recommandation OFSP dédiée au rattrapage vaccinal des requérants d'asile ; les titres d'anticorps ne servent qu'en de rares situations.

Question : Quelle recommandation OFSP/CFV fixe le rattrapage vaccinal des requérants d'asile et des migrants sans carnet (vaccins prioritaires à l'arrivée en centre fédéral, schémas de rattrapage, sérologies utiles : rougeole, varicelle, hépatite B) ? Quelles différences avec la version précédente ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-049 — Haute — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › LOT 235 Plan et Liste › Lacunes restantes (lacune #20) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › MINI (lacune #38) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S19] (lacune #39) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Échelle diagnostique post-traumatique (Posttraumatic Diagnostic Scale, (lacune #40) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Liste de symptômes de Hopkins (Hopkins Symptom Checklist, HSCL) (lacune #41) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Questionnaire international du trauma (International Trauma Questionna (lacune #42) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Questionnaire international du trauma (International Trauma Questionna (lacune #43) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Dépistage de santé du réfugié à 15 items (Refugee Health Screener-15, (lacune #44) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Dépistage de santé du réfugié à 15 items (Refugee Health Screener-15, (lacune #45) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › Lacunes restantes (lacune #58)

Contexte : Le cours cite MINI, PDS, HSCL (63,1 % de symptômes chez les requérants en 2014), ITQ et RHS-15 (52 % positifs en Allemagne) sans seuil, sans validation suisse ; aucun outil suisse validé de dépistage psychique n'est connu.

Question : Quels seuils de positivité publiés retenir pour le RHS-15, la HSCL-25, l'ITQ, la PDS et le PHQ-9 chez les réfugiés, avec sensibilité et spécificité ? Existe-t-il un outil validé ou recommandé en Suisse (SEM, OFSP, Croix-Rouge suisse, centres ambulatoires pour victimes de torture) pour le dépistage psychique des requérants d'asile ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-050 — Haute — LOT 235 · SSP O7.13 ; O7.14

Emplacement : LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #50) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › Lacunes restantes (lacune #60) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #107) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #111) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #112) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #115) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #116)

Contexte : Le cours traite le TSPT et la dépression par sertraline (Zoloft®) selon l'IP seule ; il ne cite aucune ligne directrice suisse du TSPT ni de la dépression, ni durée de traitement, ni critère de rémission, ni critère de recours au psychiatre.

Question : Quelles recommandations suisses fixent la prise en charge du TSPT (SSPP, SGPP 2024 ou plus récentes) et de la dépression unipolaire (SSAD/SGAD 2016 ou mise à jour) : psychothérapies de première ligne, antidépresseurs de choix, durée de traitement après rémission, critères de rémission (PHQ-9 < 5, MADRS) et critères d'adressage au psychiatre ? À défaut, donne les recommandations NICE/ISTSS ou WFSBP les plus récentes. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-051 — Haute — LOT 235 · SSP O7.13 ; O7.14

Emplacement : LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html ; LOT_236_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_236_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Insuffisance hépatique (classes de Child-Pugh) (lacune #46) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Électrocardiogramme (ECG) avec intervalle QTc (lacune #47) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Électrocardiogramme (ECG) avec intervalle QTc (lacune #48) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #49) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2

› LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › [S50] (lacune #51) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › syndrome malin des neuroleptiques (lacune #52) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #53) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #54) ; LOT 236 Plan et Liste › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #10) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #101) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #105) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #106) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #108) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #110) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #113) ; LOT 236 Partie 3 DX.6 a DX.7 › LOT 236 : Réadaptation physique et psychosociale, hospitaliè (lacune #114)

Contexte : Pour la sertraline, le cours donne : 50 mg/j, paliers ≤ 50 mg/semaine, maximum 200 mg/j, Child A/B moitié, Child C contre-indiquée, arrêt progressif ; hyponatrémie < 135 mmol/L, QTc et syndrome sérotoninergique cités sans calendrier de natrémie, sans seuil de QTc, sans seuil de DFGe ni conduite détaillée ; le score de Child-Pugh n'est pas détaillé.

Question : Que fixe l'IP suisse actuelle de Zoloft® et des génériques pour l'adaptation rénale, le calendrier de contrôle de la natrémie, le seuil de QTc ou la conduite ECG ? Quelles recommandations européennes donnent un seuil d'arrêt du QTc (> 500 ms ou + 60 ms) et la conduite devant un syndrome sérotoninergique (critères de Hunter, cyproheptadine) ou un syndrome malin des neuroleptiques ? Quels sont les items et points du score de Child-Pugh ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-055 — Haute — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #116) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #117) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › ③ Praziquantel — non autorisé en Suisse (importation) (lacune #119) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › Lacunes restantes (lacune #128) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › Lacunes restantes (lacune #130)

Contexte : Le cours suit l'ECDC et la SIMET : prévalence européenne de schistosomiase > 17 % chez les migrants subsahariens ; praziquantel 40 mg/kg/j absent de la liste Swissmedic (30.09.2026), à importer ; critères formels de strongyloïdose et prévalence suisse inconnus.

Question : Comment obtient-on en Suisse le praziquantel (Biltricide®) et l'ivermectine (Stromectol®, Scabioral®) pour la schistosomiase et la strongyloïdose (importation, autorisation, remboursement), et à quelles doses ? Quelle stratégie suisse (Swiss TPH, OFSP) recommande le dépistage ou le traitement présomptif chez le migrant ? Existe-t-il des données suisses de prévalence ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre,

organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-057 — Haute — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Hémogramme, ferritine et HPLC de l'hémoglobine (lacune #11) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › Calcul dérivé : teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine (lacune #123) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #124) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c › syndrome thoracique aigu (lacune #125) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #126) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #127) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › Lacunes restantes (lacune #132)

Contexte : Le cours utilise le NICE CG143 (crise vaso-occlusive) faute de recommandation suisse ; TCMH < 27 pg et HbA2 ≥ 3,5 % sans limite normale ; anémie de grossesse < 110 g/L (étude bâloise) ; le traitement du syndrome thoracique aigu n'est pas donné.

Question : Existe-t-il une recommandation suisse (Société suisse d'hématologie, SSP pédiatrie) ou européenne récente (EHA, ERN-EuroBloodNet) pour la drépanocytose : crise vaso-occlusive (analgésie, hydratation), syndrome thoracique aigu (antibiotiques, oxygène, transfusion d'échange), hydroxyurée ? Quels sont les intervalles de référence de la TCMH et de l'HbA2 et la stratégie de dépistage des hémoglobinopathies en grossesse en Suisse ? Pour chaque médicament, donne la spécialité suisse, la dose, la voie, la durée et les adaptations (rein, foie, enfant, grossesse) selon l'information professionnelle suisse (swissmedicinfo.ch), avec la date de l'IP. Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-046 — Moyenne — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_A_V5_Ultra_Pedagogique_Plan_et_Liste.html ; LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_1_DX.1_a_DX.2.html › LOT 235 Plan et Liste › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #3) ; LOT 235 Plan et Liste › Lacunes restantes (lacune #15) ; LOT 235 Partie 1 DX.1 a DX.2 › Lacunes restantes (lacune #56)

Contexte : Le cours écrit que l'état de santé récent de la population migrante (monitoring OFS/Obsan) n'a pas été trouvé ; 9 % de la population a une langue principale non nationale.

Question : Quelles sont les données les plus récentes du monitoring suisse de la santé de la population migrante (OFS, Obsan, OFSP « Santé des migrants », enquête ESS 2022), avec

indicateurs clés et URL ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-054 — Moyenne — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_3_DX.6_a_DX.7.html › LOT 235 Partie 3 DX.6 a DX.7 › Lacunes restantes (lacune #114)

Contexte : Le cours n'a pas trouvé les chiffres suisses du paludisme 2020–2025 ni la proportion de voyageurs VFR.

Question : Combien de cas de paludisme l'OFSP a-t-il déclarés par année de 2020 à 2025, avec la part de P. falciparum, la proportion de migrants rendant visite à leur famille (VFR) et la létalité ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

C-056 — Moyenne — LOT 235 · SSP O7.13

Emplacement : LOT_235_Appel_B_V5_Ultra_Pedagogique_Partie_4_DX.8_a_DX.10.html › LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #120) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › LOT 235 : Patient d'un autre contexte culturel, migration (c (lacune #121) ; LOT 235 Partie 4 DX.8 a DX.10 › Lacunes restantes (lacune #131)

Contexte : Le cours traite l'excision et les mutilations génitales féminines (inspection clinique, désinfibulation, programme OFSP/SEM) sans critère de guérison ni recommandation clinique suisse citée.

Question : Quelles recommandations suisses s'appliquent aux mutilations génitales féminines (avis d'experts SSGO, Réseau suisse contre l'excision, CP 124), avec classification OMS, prise en charge obstétricale et désinfibulation, version et URL ? Donne la recommandation suisse en vigueur (titre, organisme, année, URL), compare-la à la version citée dans le cours et liste les différences ; à défaut de source suisse, donne la recommandation européenne la plus récente.

Réponse :

1. Recommandation suisse la plus récente (société/autorité, titre, année, URL) :
2. Version citée dans le cours et différences :
3. Informations, doses, posologies (AIPS, n° d'autorisation) :
4. Source européenne (si aucune source suisse) :
5. Extrait mot pour mot + date de consultation :
6. Certitude et réserves :

FIN DU PAQUET HELP_Organi_P14 — 16 questions : C-036, C-037, C-038, C-044, C-045, C-035, C-047, C-048, C-049, C-050, C-051, C-055, C-057, C-046, C-054, C-056